

PQR, derechos, humanización y satisfacción

Procedimiento | Alcance base: fisioterapia | Estado: propuesta para adopción

1. Objetivo y resultado esperado

Facilitar solicitudes, trato digno, comunicación accesible y mejora de atención sin represalias ni exposición de información clínica.

2. Alcance y condiciones de uso

Derechos y deberes del paciente, recepción y respuesta de solicitudes y quejas. Los plazos legales se determinan por clase de petición y norma aplicable; no se asigna un plazo único a todas.

3. Responsabilidades por rol

Rol	Responsabilidad
Fisioterapeuta responsable	Valorar, individualizar, informar, vigilar y registrar.
Ejecutor según proceso	Aplicar la técnica o tarea para la que tiene competencia.
Verificador o titular	Comprobar recursos, evidencias y acciones de mejora.

4. Recursos y preparación

Mantener documento vigente, responsables reales, recursos de la actividad y soportes del emisor o fabricante pertinentes. Antes de ejecutar comprobar disponibilidad y seguridad; si falta un recurso crítico, controlar el riesgo y registrar suspensión o alternativa.

Secuencia operativa y decisiones

El orden se adapta al episodio sin omitir los controles de seguridad. Las técnicas y parámetros concretos se definen por competencia, evidencia y fabricante; no se completan con valores de ejemplo.

1. Publicar canales y explicar derechos, privacidad, decisión sobre contacto, posibilidad de

Publicar canales y explicar derechos, privacidad, decisión sobre contacto, posibilidad de acompañante y trato sin discriminación. Mantener información accesible para quienes no usan medios digitales.

2. Recibir solicitud con datos mínimos y radicado, fecha, canal y asunto

Recibir solicitud con datos mínimos y radicado, fecha, canal y asunto. Identificar si implica riesgo inmediato, urgencia clínica, acceso a historia, datos personales u otro trámite.

3. Asignar responsable y plazo según naturaleza y regulación aplicable

Asignar responsable y plazo según naturaleza y regulación aplicable. Una queja clínica urgente exige control del riesgo, sin esperar término administrativo.

4. Analizar con hechos y consultar responsables

Analizar con hechos y consultar responsables. Responder de forma comprensible por canal autorizado, evitando datos de terceros y lenguaje intimidatorio.

5. Registrar respuesta, entrega, medidas y posibilidad de seguimiento

Registrar respuesta, entrega, medidas y posibilidad de seguimiento. Aplicar encuesta voluntaria con datos mínimos y no usar satisfacción como única medida de resultado clínico.

6. Consolidar tendencias de acceso, información, respeto, tiempo y continuidad

Consolidar tendencias de acceso, información, respeto, tiempo y continuidad. Definir mejora medible, evaluar eficacia y comunicar cambios al equipo.

Control, frecuencia y corrección

5. Verificación de la ejecución

Registro y canal de respuesta trazables.

Respuesta por clase de solicitud.

Encuesta sin presión y con privacidad.

Momento	Comprobación y conducta
Antes	Verificar alcance, recurso y condición de uso descritos. Resolver discrepancias antes de comenzar; documentar aplazamiento cuando no es seguro.
Durante	Seguir los pasos de este documento y registrar modificaciones, novedades y actuaciones reales. Detener ante los criterios de riesgo del proceso.
Después	Comprobar resultado, integridad, limpieza o continuidad según proceso. Vincular registro y autor, sin dar por cumplida una tarea no observada.
Ante hallazgo	Contener el riesgo, describir causa, asignar acción y comprobar eficacia. Mantener abierto el pendiente mientras no exista evidencia de cierre.

6. Registro, conservación y seguimiento

Utilizar la ficha o formato asociado y conservar fecha, episodio, ejecutor y soporte. Los registros clínicos se incorporan a la historia reservada; documentos laborales y administrativos tienen acceso según su finalidad. Reproducir páginas de registro cuando se necesita espacio, sin condensar la información clínica ni registrar valores supuestos.

7. Aplicación normativa específica

11.1.5 y 11.3.1.22-26: información documentada, prácticas seguras, recursos y formación. Limitar técnicas al portafolio y verificar condiciones reales.

8. Adopción y revisión

Completar responsables y condiciones de sede, leer referencias y manuales íntegros, validar el proceso y socializarlo. Registrar versión adoptada y autenticación; revisar ante cambio de norma, producto, equipo, técnica o hallazgo y en el ciclo local anual. Frecuencias y metas locales de esta edición no se presentan como exigencias legales universales.

Ficha de aplicación y referencias

Registro vacío para reproducir. Completar solo con hechos reales; identificar el documento o expediente al que pertenece. No incluye nombre, logo ni firmas preincorporadas.

Radicado fecha canal	
Tipo de solicitud	
Asunto y riesgo	
Responsable	
Plazo y fundamento	
Análisis	
Respuesta	
Medio de entrega	
Acción	
Cierre y satisfacción	

Fuentes y límites

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes; manual, criterios generales 11.1 y servicio de terapias 11.3.1. Resolución 2080 de 2026, artículo 1: revocatoria integral de 1732 de 2026; no se utiliza su manual como exigencia vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Datos sensibles

Ley 1581 de 2012, artículos 4-6, 8-12 y 17-18; Decreto 1074 de 2015, reglas de tratamiento. Información de salud y finalidades opcionales requieren análisis de base jurídica, autorización cuando exigible y seguridad.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981>

Derechos y petición

Ley 1751 de 2015, acceso y derechos en salud; Ley 1755 de 2015 para peticiones aplicables. Plazos y protección se determinan por naturaleza del trámite; no se asigna un plazo universal a PQR, acceso clínico o protección de datos.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=60733>

Aprobó

Eliana Milena Pardo Ríos

TP 60576